

Ujawnianie *bliskim*

Decyzja o tym, komu, ile i jak powiedzieć o traumie i o PTSD — jest indywidualna. Ten handout daje ramę do rozważenia: kto, co, kiedy, jak — bez gotowej odpowiedzi.

CZAS: 30 min · refleksja Decyzja indywidualna **ŹRÓDŁO:** Brewin & Holmes (2003); Herman (1992)

JAK UŻYWAĆ

Decyzja o ujawnieniu obejmuje **cztery wymiary**: **1) komu** (partner · członkowie rodziny · bliscy przyjaciele · znajomi · pracodawca · ogół), **2) co** (sam fakt PTSD · ogólne kategorie objawów · konkretne wyzwalać · sama trauma), **3) kiedy** (zaraz · po stabilizacji · w trakcie terapii · po terapii · nigdy), **4) jak** (twarzą w twarz · pisemnie · przez bliską osobę · podczas konkretnej sytuacji). **Nie ma jednej dobrej odpowiedzi** — zależy od: relacji, etapu Twojej pracy, gotowości odbiorcy, kontekstu sytuacji. Co najważniejsze: *ujawnienie nie jest „wszystko albo nic”*. Można ujawnić jedną warstwę i obserwować reakcję, zanim przejdzie się do głębszej.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Brewin i Holmes (2003) wykazali, że *wsparcie społeczne* jest jednym z najsilniejszych czynników rokowniczych w PTSD: pacjenci z dobrą siecią wsparcia mają **30-40% lepsze wyniki** w 5-letniej obserwacji. *Ale*: ta korelacja zależy od **jakości** wsparcia, nie liczby ujawnień. Niewłaściwe ujawnienie (osobie niegotowej, w niewłaściwym czasie) może *pogorszyć* sytuację: pacjent doświadcza zminimalizowania, obwiniania, ciekawości zamiast empatii. Herman (1992) podkreślała, że *pierwsze ujawnienia* powinny być w bezpiecznych kontekstach (terapia, grupa wsparcia, jedna sprawdzona osoba), zanim pacjent rozszerzy krąg. Ujawnienie to nie obowiązek — to **wybór strategiczny**, służący Twojemu zdrowiu, nie czyjeś ciekawości.

01 Cztery warstwy ujawnienia — gradient

A · FUNKCJONALNE

„Mam okresy, kiedy potrzebuję mniej bodźców / wcześniejszego końca dnia / zrozumienia, gdy reaguję inaczej”. *Bez diagnozy, bez traumy.*
Najbezpieczniejsze dla relacji zawodowych i znajomych.

B · DIAGNOSTYCZNE

„Mam PTSD. Leczę się. To może wpływać na pewne sytuacje”. *Diagnoza tak, trauma jako szczegół — nie.*
Dla partnera, najbliższej rodziny, czasem zaufanego pracodawcy.

C · KONTEKSTOWE

„Doświadczyłam/-em traumy [ogólny opis: napaść / wypadek / przemoc]”. *Ogólny rodzaj zdarzenia, bez szczegółów.* Dla najbliższych — partnera, jednego-dwojga rodziców, najbliższej przyjaciółki.

D · PEŁNE

Szczegóły traumy. *Tylko z terapeutą, ewentualnie z bardzo sprawdzoną pojedynczą osobą.* Zwykle **nie jest konieczne** dla zdrowia. Świadkowie szczegółów też mają swoje reakcje, które potem niesiesz.

02 ◎ Cztery pytania przed ujawnieniem

1 • PO CO UJAWNIAM?

Konkretna potrzeba (zrozumienie reakcji, prośba o wsparcie, prośba o dostosowanie)? Czy potrzeba autentyczności? Pierwsze często wymaga ujawnienia; drugie często wystarczy „mam okresy trudne”.

2 • CZY ODBIORCA JEST GOTOWY?

Jak reagował dotąd na trudne tematy? Czy ma kompetencje emocjonalne? Czy *w tym momencie życia* ma przestrzeń (nie w trakcie własnego kryzysu)?

3 • CZY JA JESTEM GOTOWY/-A?

Czy mam okno tolerancji, by przejść przez rozmowę? Czy mam zasoby na ewentualną nieoczekiwaną reakcję? Mam plan na po rozmowie?

4 • CZEGO POTRZEBUJĘ OD TEJ OSOBY?

Wsparcia? Słuchania? Konkretnej pomocy? **Powiedz wprost.** „Potrzebuję, żebyś słuchał, nie radził” — to bardzo pomocne.

03 ✕ Trudne reakcje — i jak je przyjąć

MINIMALIZOWANIE

„Každemu coś się dzieje”, „nie jest aż tak źle”. *Nie próbuj przekonywać.* Powiedz: „Dla mnie to jest poważne. Potrzebuję tylko żebyś o tym wiedział/-a”.

NADMIAR PYTAŃ

Czasem ciekawość, czasem chęć pomocy. „Nie chcę teraz opowiadać szczegółów. To, co powiedziałam/-em, wystarczy”.

NIEPROPORCJONALNE EMOCJE

Druga osoba płacze, jest w panice, przeprasza. *Możesz wycofać się.* „Widzę, że jest Ci trudno. Wrócimy do tego później”.

OBWINIANIE

„Może powinnaś/-eś była...”, „Dlaczego nie...”. **To czerwona flaga relacji.** Wycofaj się z dalszych ujawnień u tej osoby.

Klucz: ujawnienie powinno służyć *Twojemu* zdrowieniu, nie potrzebie wyjaśnienia czegoś świata. Czasami najlepszym wyborem jest *nie ujawniać* — i to też jest zdrowy wybór. Twoja prywatność należy do Ciebie. Trauma to to, co Cię spotkało — nie definicja tego, kim jesteś. Czy o niej mówisz, komu i kiedy — należy do Twojej autonomii, którą trauma próbowała odebrać.